

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Hypoglycémie

Conduite à tenir devant hypoglycémie suspectée ou confirmée, chez un résident diabétique ou non, hors détresse vitale.

Indications

- Glycémie capillaire basse ou symptômes compatibles.
- Sueurs, pâleur, tremblements, faim, agitation ou confusion.
- Contexte de traitement hypoglycémiant ou repas insuffisant.

Vérifications préalables

- Mesurer la glycémie capillaire si possible.
- Évaluer conscience, capacité à avaler et signes neurologiques.
- Vérifier traitement reçu, horaire du dernier repas et effort récent.
- Installer le résident en sécurité.

Ne pas appliquer ce protocole

- Trouble de conscience ou impossibilité d'avaler.
- Convulsions, inhalation, vomissements ou détresse associée.
- Récidive rapide malgré correction.
- Malaise grave ou diagnostic incertain.

Conduite à tenir

- Si résident conscient : donner 15 g de glucides rapides per os (ex. 3 morceaux de sucre standard ou 3 sachets de 5 g).
- Recontrôler la glycémie après 15 minutes si possible.
- Si amélioration : compléter par collation glucidique ou repas.
- Prévenir le médecin si épisode inhabituel ou adaptation nécessaire.

Surveillance et traçabilité

- Tracer symptômes, glycémies, quantité de sucre et évolution.
- Surveiller conscience, récurrence et prise alimentaire secondaire.
- Noter le contexte thérapeutique.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si hypoglycémie persistante, récidivante ou mal tolérée.
- Appel 15 si trouble de conscience, convulsions, impossibilité d'avaler ou détresse vitale.

Mention de sécurité

Chez un résident non conscient : aucune administration per os. Toujours recontrôler et rechercher la cause de l'épisode.

Fait à :

Le : / /

Signature :